

Impact des IVG sur la prématurité

Analyse de l'étude EUROPOP

Olivier CARON Lina CHEKROUN Sandra SINNASSAMY

March 15, 2025

Présentation de l'article «History of induced abortion as a risk factor for preterm birth ...»

- **Référence complète:**

Ancel P.-Y., Lelong N., Papiernik E., Saurel-Cubizolles M.-J., Kaminski M. (2004). *History of induced abortion as a risk factor for preterm birth in European countries: results of the EUROPOP survey*. Human Reproduction, 19(3): 734–740.

Contexte et Objectifs de l'étude

- **Contexte**

- Impact potentiel des avortements induits sur la santé reproductive.
- Risque accru d'accouchement prématuré (suggéré par études antérieures).

- **Objectif principal**

- Investiguer la relation entre l'historique d'avortements induits et le risque de prématurité.
- Comparer ces effets dans différents pays européens.

- **Type d'étude:** Étude *cas-témoins* (EUROPOP) menée entre 1994 et 1997.
- **Population**
 - Cas : 2938 naissances prématurées (22-36 SA).
 - Témoins : 4781 naissances à terme (>37 SA).
- **Pays inclus:** 10 pays européens (ex. Allemagne, Finlande, Italie, Russie, etc.).
- **Critères d'exclusion:** Absence ou confusion dans la déclaration des avortements, données manquantes.

- **Recueil de données**

- Questionnaire pendant le séjour à la maternité.
- Données sur :
 - Facteurs sociodémographiques (âge, statut marital, etc.).
 - Historique obstétrical (avortements, naissances précédentes).
 - Comportements (tabagisme).

- **Catégories d'avortements induits**

- 0, 1, ou ≥ 2 avortements.

- **Analyse**

- Ajustements pour facteurs de confusion : âge, parité, tabagisme, etc.
- Calcul d'**Odds Ratios (OR)** et IC 95%.

- **Association avortement induit / prématurité**
 - OR global ajusté ~1,2-1,5 si ≥ 1 avortement.
 - Risque plus élevé (OR = 1,63) pour ≥ 2 avortements.
- **Causes de la prématurité**
 - Risque augmenté pour :
 - Rupture prématurée des membranes (OR = 1,35).
 - Travail prématuré idiopathique (OR = 1,31).
 - Hémorragie antepartum (OR = 1,65).
 - Pas d'association avec hypertension maternelle.
- **Effet selon le terme**
 - Association plus forte pour la prématurité très précoce (22-32 SA) que modérée (33-36 SA).

- **Conclusion**

- Historique d'avortements induits = facteur de risque indépendant de prématurité.
- Effet dose-réponse (plus d'avortements => risque plus élevé).
- Pas de différence majeure selon le pays, malgré des pratiques variées.

- **Limites**

- Biais de déclaration (sous-déclaration possible des IVG).
- Biais de sélection (échantillon de maternités volontaires).
- Pas de distinction précise entre différentes techniques d'IVG.

1. Population étudiée

- Femmes ayant accouché prématurément (cas) vs. femmes ayant accouché à terme (témoins), dans 10 pays européens (≈ 7700 femmes).

2. Type d'étude et avantages/inconvénients

• Cas-témoins

- *Avantages*: Rapide, adapté aux événements rares (prématurité).
- *Inconvénients*: Biais de sélection, dépend de la mémoire des patientes (déclaration).

3. Pertinence de l'étude cas-témoins

- Oui, car la prématurité est un événement relativement rare. Une cohorte prospective serait plus coûteuse et plus longue.

4. Biais potentiels

- Sous-déclaration d'IVG (biais de déclaration).
- Biais de sélection (participation non aléatoire des maternités).
- Résultats potentiellement sous-estimés.

5. Exemple d'interprétation d'un OR dans un tableau

- **Analyse globale**

- Étude solide suggérant un lien robuste entre IVG et prématurité.
- Renforce l'importance du suivi gynécologique et obstétrical, notamment chez les femmes avec antécédents d'IVG multiples.

- **Perspectives**

- Nécessité d'enquêtes complémentaires (cohortes prospectives) pour confirmer la causalité et préciser le rôle des techniques d'avortement.
- Intérêt d'études sur la prévention d'éventuelles complications infectieuses ou mécaniques après IVG.